

 UNCAUS UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL		SALUD COLECTIVA Y COMUNITARIA “Plan de estudio Res. N° 429/2022-C.S.”	
Carga Horaria: 90 horas Teóricas: 45 horas Prácticas: 45 horas		Programa vigente: Implementación del Plan de Estudios 2022 (Res. N° 429/2022-C.S.) y Coexistencia del Plan de Estudios 2013 (Res. N° 019/13 - C.S.).	
Carrera		Año	Cuatrimestre
MEDICINA		TERCER	CUATRIMESTRAL
CORRELATIVAS PRECEDENTES			CORRELATIVAS SUBSIGUIENTES
Asignaturas			Asignaturas
Para cursar		Para rendir	-Medicina General I -Consumos problemáticos -Medicina General II
Regularizadas	Aprobadas	Aprobadas	
✓ Redes y Sistemas de Salud	• Contexto Social del Proceso Salud-Enfermedad • Hábitat, Ecología y Salud • Interculturalidad y Salud	➤ Redes y Sistemas de Salud	
DOCENTES:		Docente Titular: Méd Natalia E. JUDIS Docente Adjunta: -Lic. Edit. R. AGUIRRE Docente JTP: Lic. Sandra. RIVERO	
FUNDAMENTACIÓN:		El perfil del estudiante se orienta al médico con formación general, entendiendo por ello la capacidad de resolver los problemas principales y más frecuentes de salud de la población y con la capacidad para abordar la problemática de comunidades. Al finalizar la unidad de aprendizaje debe ser capaz de comprender que los escenarios reales en donde el proceso salud enfermedad ocurre es en el mismo ámbito en donde las personas se desenvuelven; por lo tanto, no pueden ser descontextualizados ni individualizados ya que son seres sociales. Del mismo modo, es importante desestructurar la idea que lo comunitario está automáticamente asociado a la salud y a lo preventivo. Los problemas de salud incuban en los escenarios comunitarios y la recuperación y rehabilitación supone importantes reestructuraciones y adecuaciones de los ámbitos familiares que los graduados deben conocer.	
OBJETIVOS:		General: ✓ Promover en el estudiante la comprensión de los marcos y las dinámicas de cambio de las prácticas sociales en salud y los principales elementos que los condicionan desarrollando propuestas e iniciativas de intervención desde el nivel local y comunitario hasta niveles	

	superiores, de gobierno por ejemplo nacional e incluyendo organismos internacionales. Específicos: ✓ Que los estudiantes construyan conocimiento a partir del Análisis de Situación de Salud (ASIS) y Proyecto Local Comunitario (PLP) ✓ Que los estudiantes conozcan y comprendan las condiciones de la organización de los actores (RRHH) que conforman la fuerza laboral del equipo y el sistema local de salud, identificando y remitiendo genealógicamente su estado actual al origen y evolución de los diversos movimientos que surcan el campo local y global de la salud pública. ✓ Que los estudiantes puedan contrastar y comparar los diferentes modelos prevalentes de prácticas y gestión en salud para el diseño, la planificación estratégica situacional y la programación participativa en la lógica de organizaciones y prácticas que no pueden permanecer inmutables frente a nuevos, renovados o reemergentes desafíos socio sanitarios.
CONTENIDOS MÍNIMOS:	Salud Pública y salud colectiva. Sistema de salud. Redes de salud. Epidemiología en los servicios de salud. Factores culturales. Equidad e igualdad. Bioestadística. Intersectorialidad. Políticas de salud. Agentes y actores sociales. Aspectos legislativos. APS y participación comunitaria. Educación para la salud. La salud en la Argentina y en el mundo. Patologías regionales. Indicadores básicos: demográficos, socioeconómicos, morbilidad, mortalidad. ASIS. PLP.
MÉTODOS PEDAGÓGICOS:	Método de Enseñanza y aprendizaje: El núcleo se desarrolla mediante seminarios semanales, seminarios integradores con temas basados en casos clínicos y de índole participativa para el estudiante. Actividades grupales autorizadas para el desarrollo del Análisis de Situación de Salud (ASIS) y Proyecto Local Participativo (PLP): trabajo grupal, cuatrimestral, obligatorio y de aplicación práctica de la teoría. Instancias de consulta con expertos.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN:	La unidad de aprendizaje tendrá dos (2) instancias de evaluación parcial consistentes en resolución de problemas, así se evaluará la adquisición de contenido teórico y su aplicación en la práctica. Además, se realizará una evaluación continua de carácter individual y grupal mediante la presentación de Trabajos Prácticos periódicos.

	También se realizará una evaluación integral al finalizar cursada mediante la presentación del ASIS y PLP. Se tomará un examen final integrador de carácter teórico-práctico que contendrá una revisión de los contenidos conceptuales y trabajos prácticos. Se aplica la normativa vigente. Res. 080/12.-C.S. Estrategia Metodológica: • Clases teóricas presenciales: Uncaus virtuales: Meet • Clases teórico- prácticas: devolución de análisis de casos grupales. • Desarrollo de los contenidos mínimos del núcleo. • Utilización de PowerPoint. Recursos Didácticos: • PC • Cañón proyector • Bibliografía (disponibles en plataforma virtual del núcleo) Criterio de acreditación: • Modalidad Presencial: Sistema de evaluación parcial: consistirá en 2 (dos) exámenes escritos de tipo estructurado a desarrollar y de opciones múltiples, aprobadas con calificación mínima de 6 (seis). Sistema de evaluación final: consistirá en examen oral con programa del núcleo. Aprobado con calificación mínima de 6 (seis). Trabajos prácticos aprobados: 80% incluyendo el PLP y ASIS. Asistencia a clases teóricas: 80%. • Criterio de evaluación: El estudiante deberá demostrar conocimiento acerca de las bases científicas del núcleo relacionadas con su profesión. El estudiante deberá aplicar la metodología y desarrollar en el Análisis de situación de salud y Proyecto local participativo en el abordaje integral de la persona- familia- comunidad. El estudiante deberá conocer y utilizar adecuadamente la terminología requerida en el núcleo en cuanto a su profesión. El estudiante deberá demostrar una actitud de respeto hacia sus compañeros, docentes y la institución. • Instancias evaluatorias: Dos (2) exámenes parciales aprobados, con un (1) recuperatorio por parcial. Trabajos teóricos- prácticos. Examen final oral.
PROGRAMA ANALÍTICO DE CONTENIDOS:	Núcleo 2: Medicina /Equipo de Salud como objeto de estudio y sujeto de transformación.

En el segundo módulo, los polos de la diada constituida tensionan el cuerpo disciplinar de la medicina como institución, como cosa instituida, frente a los cambios que generan los nuevos discursos que transitan el universo de las prácticas en salud. Una medicina de la que formamos parte, pero al mismo tiempo somos creadores junto a otros tantos sujetos e instituciones de nuestro país en íntima relación con el contexto social, económico, cultural y político global. La tensión en este caso se da entre una medicina centrada exclusivamente en la relación individual médico-paciente, y una medicina más amplia, que articula el equipo de salud y la institución a la mantención y reparación de la salud poblacional.

Núcleo 3: Salud internacional/APS: de lo local a lo global y viceversa.

En este tercer módulo abordamos la articulación local/global desde las afluentes que conforman los movimientos de la salud colectiva y comunitaria, junto al impulso fundamental que significó la proclamación internacional de la estrategia de APS para comprender cómo se van constituyendo las diferentes categorías y prácticas que permiten superar la visión tecnicista y los modelos de la salud pública tradicional, y fundamentar una propuesta de una salud colectiva y comunitaria contextualizada e integral.

Núcleo 4: Políticas nacionales/Sistemas comparados: compararse con otros; compararse consigo mismo.

En el cuarto y último módulo examinaremos a las políticas y los sistemas nacionales de salud como partes de un todo, en tensión con la visión que presenta a las actividades, programas y planes de salud estatales como una colección desarticulada de acciones parciales, ineficaces o exitosas en algunas ocasiones, más acordes a la gerencia de un mercado médico-farmacéutico que fija su atención únicamente en la posibilidad gestionar los servicios de salud transformados en servicios de atención a la enfermedad, dejando de lado la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud por su carácter no rentable; y a pesar de ciertos avances impulsados desde otros sectores estatales con los que se deberían hilvanar aproximaciones integrales más abarcativas y contextualizadas.

Eje metodológico transversal:

Núcleo 5: Análisis del discurso

¿Cómo las distintas vertientes, perspectivas y tradiciones desde las más precursoras hasta las más recientes organizan discursivamente la relación entre actores y factores de la salud? ¿Cómo la dimensión poblacional, las prácticas tradicionales y alternativas en salud pública, sus discursos, sentidos y funcionalidades atraviesan dialécticamente el campo de la práctica médica?

Núcleo 6: Gestión de calidad centrada en el

	ciudadano. ¿Cómo se adecua la díada médico-paciente a las relaciones entre la enfermedad y los factores socioculturales, demográficos, ecológicos, económicos y políticos que determinan y condicionan la dinámica organizativa de las instituciones sanitarias? ¿Cómo entran los derechos ciudadanos y su dimensión ética en la subjetividad del eje médico-paciente? Núcleo 7: Planificación estratégica situación. Como dispositivo analítico y propositivo para la intervención en contextos de poder fragmentado. Actores, campos de fuerza, viabilidad de las acciones como ejes básicos del cambio organizacional. Núcleo 8: Programación local participativo. Un dispositivo privilegiado para comprender una APS comprensiva y emancipatoria. Lo comunitario en acto. Voces, organización, negociación, intersectorialidad. Núcleo 9: Medicina traslacional. Transferencia de conocimientos y tecnología diagnóstica o terapéutica básica desde el laboratorio a la clínica médica cotidiana. ¿Cómo asegurarse de que los nuevos tratamientos y el conocimiento científico lleguen a los pacientes y poblaciones para quienes son diseñados y sean implementados correctamente?
PROGRAMA ANALÍTICO DE TRABAJOS PRÁCTICOS:	Trabajo Práctico N°1: “Salud Pública” Conocer la historia de la salud pública en Argentina a través de una línea de tiempo con hechos históricos relevantes. Integrar el concepto de salud como derecho mediante la legislación vigente nacional e internacional. Trabajo Práctico N° 2: “ASIS/PLP– conociendo el terreno” Iniciamos el camino de elaboración del Análisis de la situación de Salud/PLP de un barrio o comuna en nuestra ciudad o zona geográfica cercana. Entablamos relaciones interinstitucionales con los referentes y centros de salud del área. Recorremos la zona para planificar futuras visitas. Trabajo Práctico N° 3: “Sicko” Ampliar el conocimiento previo de sistemas de salud en Argentina y en el mundo mediante el material audiovisual documental denomina “Sicko”. Elaborar una visión crítica individual con respecto a los diferentes sistemas. Trabajo Práctico N° 4: “Salud colectiva y comunitaria” Mediante la lectura crítica de trabajos científicos elaborar un marco conceptual de las diferentes connotaciones del concepto de salud individual y colectiva. Interpretar el rol del Estado y del Salubrista hoy.

	Trabajo Práctico N° 5: “ASIS/PLP – Entrevista” Elaborar de manera individual un amplio marco de conocimiento de la realidad demográfica, socio-comunitaria, económica y política del territorio asignado. Trabajo Práctico N° 6: “ASIS/PLP – bioestadística” Ampliar el conocimiento previo bioestadística mediante la lectura crítica del material bibliográfico y aplicarlo en el procesamiento de datos recabados en terreno, resumiendo los resultados. Trabajo Práctico N° 7: “Legislación argentina vigente” Mediante el uso de Problemas cotidianos en el ejercicio de la medicina (ABP), elaborar resoluciones que se ajusten a la legislación argentina vigente. Trabajo Práctico N° 8: “Proyecto Local Participativo (PLP)” Ampliar conocimiento acerca de participación comunitaria, diagnóstico participativo, caracterización de actores sociales. Planificación de actividades para causas abordables.
BIBLIOGRAFÍA:	Núcleo 1: Salud Colectiva/Salud individual Núcleo 2: Medicina /Equipo de Salud como objeto de estudio y sujeto de transformación. -Paim, J. S., & Almeida Filho, N. M. D. (1999). La crisis de la salud pública y el movimiento de la salud colectiva en Latinoamérica. <i>Latinoam</i> -Armus, D. (2011). De la salud pública a la salud colectiva. <i>Voces en el Fenix</i>, 2(7), 28. https://works.swarthmore.edu/fac-history/487 -Bertolotto, A., Fuks, A., & Rovere, M. (2012). Atención Primaria de Salud en Argentina: proliferación desordenada y modelos en conflicto. <i>Saúde em Debate</i>, 36, 362-374. https://www.scielo.org/article/sdeb/2012.v36n94/362-374/ -Gómez Haiss, Dante D.2017. (p.2) Núcleo 3: Salud internacional/APS: de lo local a lo global y viceversa. Núcleo 4: Políticas nacionales/Sistemas comparados: compararse con otros; compararse consigo mismo. - Laurell, Asa C. (2008) "Sobre la concepción biológica y social del proceso salud enfermedad https://digitalrepository.unm.edu/lasm_es/299 -Artaza Barrios, O., Báscolo, E., Aragüés y Oroz, V., Garay, O. E., Bello, J., & Mera, J. (2017). <i>Funciones Esenciales de Salud Pública: su implementación en Argentina y desafíos hacia salud universal</i>. ISBN: 978-950-710-127-4.

	http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34026 Núcleo 5: Análisis del discurso Núcleo 6: Gestión de calidad centrada en el ciudadano. - Santa María Juárez, L. A. (2018). Intervenciones en salud pública: bases conceptuales para la determinación de objetivos y evaluación. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 35, 321-325. https://doi.org/10.17843/rpmesp.2018.352.2967. - Armas, C. S., García, M. H., & Cofiño, R. (2018). ¿De qué hablamos cuando hablamos de «salud comunitaria»? Informe SESPAS 2018. Gaceta Sanitaria, 32, 5-12. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.07.005 Núcleo 7: Planificación estratégica situación. Núcleo 8: Programación local participativo. Núcleo 9: Medicina traslacional. -Revista cubana de salud pública. Sociedad cubana de administración de salud. 2004.Edmundo Granda. ¿A que llamamos salud colectiva hoy? -Soberanía Sanitaria-diciembre 2018. p.7. - revista de salud.revistasoberaniasanitaria.com.ar. -Funciones Esenciales de Salud Pública: su implementación en Argentina y Desafíos hacia salud universal. Organización Panamericana de la Salud.2017. p.19 - Iglesias, G. & N. Vázquez. (2009). “Propuesta de intervención como trabajo final”. En Iglesias, G. & G. Resala (coords.). -Rovere Mario.2019. (pag.34) -Organización Panamericana de la salud. Transformando los servicios de salud. 2017. (pag. 65)
--	---